

--

Name: اصلاح عبد التواب محمد نصير National ID: 27612032100683	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٥٧٦

المصرية





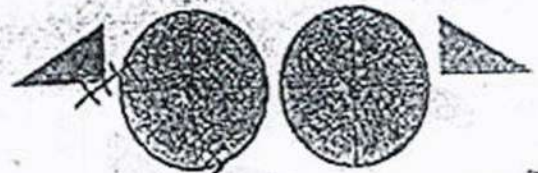
مبادرة رئيس الجمهورية
لحماية صحة المرأة المصرية

الهيئة العامة
لصحة
المرأة
مصر

PostOp MDT FORM

٢٠٢١ / ١٠ / ٢٠
٢٧١٢-٢٢١-٦٨٣
١٠١-٠٢-٠١

Name	الطاهر عبد الله
Age	45 y.
MRN	٢٧١٢
ID	٢٢١
Co morbidity	



(2)

Clinical Data

Bx:	Post NAC	SM:	
IHC:	Post WLE + SLN	Mets Workup:	
ER:			
PR:			
Hert:	Residual T- (Partial Response)		
Ki67:			
free margins ^N M, SLN 0/5			
COMMENT:	T mic No Mo		

Signature
17.10.21

MDT OUTCOME & PLAN

30/10/2021 → - PORT,
- Continue 6 mns herceptin (microinvasive yptis)
- 5 ys Endocrine tht acc. to menopause
(Tamoxifen) - then consider extended. & switch
AI + Zoladex

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
Signature	Signature	Signature	Signature

Name:	اصلاح عبدالنواب محمد	
MR. :	6493	
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	
	رقم طبي:	
إيماء للطلب المقدم من		
بقسم:		
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	
تاريخ وساعة الدخول :		
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient was diagnosed with breast cancer and was placed on aramidex in combination with zoladex 10.8 mg, with a planned duration of three months of aramidex therapy and continued zoladex administration. The patient returned for follow-up and received zoladex 10.8 mg and aramidex, with supportive treatment planned for three months, followed by a pharmacy refill. Zometa 4 mg was scheduled after laboratory results were obtained. The patient has a right-sided invasive ductal carcinoma, grade 2, staged clinically as cT2N1M0. Hormone receptor testing showed ER 8/8, PR 5/8, HER2 + 3, and Ki-67 25 %. Neoadjuvant chemotherapy consisted of four cycles of AC followed by four cycles of THP, after which the patient underwent wide local excision and sentinel lymph node biopsy, revealing pathology pTmicN0. Adjuvant therapy included trastuzumab (Herceptin) and postoperative radiotherapy. Hormonal therapy was initiated in October 2021 with tamoxifen plus zoladex for four years, then transitioned to aramidex plus zoladex for one year. For the current evaluation, serum markers and hormonal profile were ordered, and the patient reported lower back and bilateral shoulder pain, prompting a bone scan. The next dose of zoladex is due on 16/08. The patient continues on aramidex and zoladex as described.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	19-09-2026
		الطبيب المعالج :
		Ali Adel
يعتمد ,		

Patient Name : الأستاذ / صلاح عبد القادر محمد	Request No. : 135671
Patient No. : 358-2021	Request Date : 21/09/2021
Path No. : 2182	Verification Date : 30/09/2021
Sex : Female	Financial Category : أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 44 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	

Pathology Report

Clinical Data:

Right breast cancer.

Nature of the specimen:

Right wide local excision and sentinel lymph nodes excision.

Gross Examination:

- Procedure: Right WLE specimen; measured 10x9x3 cm, covering skin 6.5x3 cm, designated as LL, SS, wired and clipped.
- Localization: Right breast
- Tumor extent
 - o Number: Ill defined grayish white rubbery tumor bed site
 - o Size: 2.5x2x1 cm
 - o Skin involvement: No
- Distance from margins: Least margin 0.9 cm (medial margin)
- Lymph nodes number and size: Five nodules up to 3 cm
- Additional pathologic findings: N/A
- Immunohistochemistry technique: N/A
- Frozen section: N/A

Microscopic examination:

- Histological type: Tiny residual tumor cells (microscopic focus)
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): II
- Angiolymphatic invasion: Negative
- Ductal carcinoma in situ: Solid and cribriform variants
- o Skin involvement: No
- Lymph node involvement: Negative
- Resection Margins: Free
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response
- Additional pathologic findings: Calcifications.



ImmunohistoChemistry report

Port Number: m870

Female	النوع	اصلاح عبدالقواب محمد نصر	اسم المريض
القاهرة	العنوان	44 Y	السن
11/02/2021 11:24	تاريخ استلام العينة	مركز اورام دار السلام	تاريخ اخذ العينة
17/02/2021 14:00	تاريخ التقرير	مركز اورام دار السلام	مطالب التحليل
			عناية

Primary Sample :

Pin Block

Test :
ER & HER2 neu & Ki67 (ER&PR: Harvey scoring system -Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

Sample recieved was treated by : - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody.- CONFIRM anti-gestosterone receptor(PR) (IE2)Rabbit monoclonal primary antibody.
Sample recieved was treated by : -VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection in ventana benchmark GX.
Sample recieved was treated by : - CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbit monoclonal primary antibody.

Result :

ER: strong nuclear staining of 80 % of tumour cells
PR: moderate nuclear staining of 30 % of tumour cells
HER2/neu protein over expression : strong continuous membrane staining of > 10 % of tumor cells.
Ki67: positive nuclear staining of about 25 % of tumour cells

Referral Lab :

Comment :

Conclusion :

ER: POSITIVE (SCORE 8 / 8)
PR: POSITIVE (SCORE 5 / 8)
HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : POSITIVE (SCORE 3+)
Ki67: THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS ABOUT 25 % .
CORE BIOPSY)

Pathologist:

د/إيڤيس رمزي

Lab Director: د/عزيزا ماهر



NUCLEAR MEDICINE UNIT

وحدة الطب النووي

Patient Name: Eslah Abdeltawab Mohamed.
Referring physician: Prof.

Date: 14/4/2021

^{99m}Tc -MDP BONE SCAN

Desired information : skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique: Anterior and posterior whole body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc -MDP.

Report:

- Degenerative changes at the dorsal and lumbar vertebrae.
- Otherwise the rest of surveyed skeleton is free from serious bone lesions.
- Both kidneys are normally seen.

Conclusion:

*No definite evidence of metastatic osseous deposits.
Follow up bone scan is advised.*

Thanks for reference

Nuclear Medicine Unit
Huda Fathy, M.D
Magdy Kotb, M.D.



جنيه الاصدار : فرع القاهرة

تاريخ الاصدار : 2023-5-2

الى من يلمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للائنفاع الخاصين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس وقانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والتحقيق تبين أن

المريد (ة) اصلاح عبد التواب محمد بطاقة رقم 27612032100683

ودليقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الائنفاع
يعتبر من القدرات غير المنتفحة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون اي مسؤولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي شال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطابعه : 2023-5-2

الموظف المختص

لمسة
منش حسين

تقديم المعلومات



مستمل 663849



الخطاب ساري لمدة ثلاثة شهور من تاريخ الاصدار الا في حالة تغير حالة المواطن من قبل الهيئة التوبة للتأمينات الاجتماعية او
وزارة التضامن الاجتماعي او وزارة التربية والتعليم

الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار

Patient name: صلاح عبدالقادر محمد

Date: 30/12/2020

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Indication:

Right breast palpable lump

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- No left suspicious clusters of micro calcifications or architectural distortion detected.
- Right breast shows LOQ multiple lesions of high density, harboring suspicious microcalcifications arranged in ductal distribution occupy area about 10x1.5 cm. (measured in MLO view).
- Complementary ultrasound revealed left 4O'clock irregular spiculated hypoechoic solid mass measured about 3.5x1.2cm, multiple (about 3 lesions) smaller similar lesions seen along the same duct anterior and posterior to the main lesion with anterior ductal extension seen about 13mm from the nipple.
- No left solid or cystic masses
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex.
- Ipsilateral right axillary lymph nodes are seen with diffuse cortical thickness with effaced hilum,
- Nonspecific left axillary LN.

Opinion:

- Right breast 4O'clock suspicious mass lesions (multifocal) with ipsilateral suspicious axillary LNS, (BIRADS 4b) for histopathological correlation
- Normal left breast study

Yours truly

Dr\ Walaa Abdel _aziz (FEBR, MSc)